

Pagsusuri ng Ureter sa Ilalim ng Anesthesia

Impormasyon para sa Pasyente · Pagtukoy ng pagsikip ng ureter bago ang pagpapaayos

WARWIKI

Ito ay detalyadong pagsusuri ng ureter — ang tubo na nagdadala ng ihi mula sa bato patungo sa pantog — na isinasagawa habang kayo ay natutulog sa ilalim ng anesthesia. Pinagsasama ng inyong siruhano ang ilang pagsusuri upang matukoy nang eksakto kung saan at gaano kahaba ang pagsikip, para mapili ang tamang paraan ng pagpapaayos.

Tungkol sa Pagsusuring Ito

Mahirap sukatin mula sa labas ang pagsikip (**stricture**) ng ureter, kaya tinitingnan ito ng inyong siruhano nang direkta habang kayo ay natutulog. Depende sa pangangailangan, maaaring gamitin ang **kahit anong kombinasyon** ng mga ito:

- **Diagnostic ureteroscopy** — manipis, nababaluktot na camera na ipinapasok pataas ng ureter para tingnan ang loob.
- **Retrograde pyelogram** — contrast dye na ini-inject *pataas* ng ureter mula sa pantog, kasama ang X-ray, para makita ang daluyan.
- **Antegrade pyelogram** — kung mayroon kayong drainage tube sa bato, ang dye ay ipinapasok *pababa* mula sa itaas, sa pamamagitan ng pagsikip.
- **Cystoscopy / cystogram** — pagtingin sa pantog at X-ray ng pantog.

Ang layunin ay makakuha ng malinaw na mapa — ang lokasyon, haba, at tigtness ng pagsikip. Maaari ring maglagay o mapalit ng **stent** o drainage tube ng bato sa parehong pagkakataon.

Ligtas Ba Ito?

Oo. Ito ay karaniwang pagsusuri na may mababang panganib. Kadalasan, mayroon lamang maikling dugo sa ihi, banayad na pangangati sa pag-ihing, o banayad na pananakit sa tagiliran pagkatapos. Bihirang mangyari ang impeksiyon sa ihi o pansamantalang pangangati ng ureter; napakabihirang masaktan ang ureter. Ang anesthesia ay karaniwang ligtas.

MGA TERMINO

Ureter

Ang tubo na nagdadala ng ihi mula sa bato patungo sa pantog.

Stricture

Pinasikip na lugar na may peklat na nagpapabagal o naghahadlang sa daloy ng ihi.

Ureteroscopy

Pagtingin sa loob ng ureter gamit ang manipis, nababaluktot na camera.

Retrograde pyelogram

X-ray ng ureter at bato pagkatapos ini-inject ang dye pataas mula sa pantog.

Antegrade pyelogram

X-ray pagkatapos ilagay ang dye pababa mula sa drainage tube ng bato.

Nephrostomy tube

Isang tubo na nagpapalabas ng ihi mula sa bato sa pamamagitan ng likod; maaari itong gamitin para sa dye.

Contrast dye

Isang likido na lumilitaw na puti sa X-ray para makita ang daluyan.

Stent

Malambot na panloob na tubo na nagpapanatiling bukas ang ureter; maaaring ilagay o palitan.

MASAKIT BA? Natutulog kayo sa ilalim ng anesthesia, kaya wala kayong nararamdaman. Pagkatapos, asahan ang banayad na pangangati sa pag-ihi, sakit sa tagiliran, o kaunting dugo sa ihi sa loob ng isa o dalawang araw. Maikli ito, kadalasang same-day.

Paano Maghanda (Bago ang Pagsusuri)

- Ito ay isinasagawa sa ilalim ng **anesthesia** — sundin ang lahat ng tagubilin para sa operasyon (pag-aayuno, at kung aling gamot ang ipagpapaliban, kasama ang blood thinners).
- Ang **urine test** ay titingnan kung may impeksiyon — kailangang gamunan muna ang anumang aktibong impeksiyon.
- Iwanan ang anumang kasalukuyang **drainage tube ng bato o stent**, at **mag-ayos ng sasakyan pauwi**.

Sabihin sa inyong care team nang maaga kung kayo ay:

- Nakaranas na ng reaksiyon sa **contrast dye para sa X-ray o iodine**
- Umiinom ng **blood thinner**, o may mga palatandaan ng impeksiyon sa ihi

Ano ang Nangyayari sa Pagsusuri

- 1 Natutulog kayo sa ilalim ng anesthesia at binibigyan ng antibiotics.
- 2 Isang cystoscope ang ipinapasok sa pantog. Ini-inject ang dye pataas ng ureter habang kinukuha ang X-ray, at/o isang camera ang ipinapasok pataas ng ureter para tingnan ang loob.
- 3 Kung mayroon kayong drainage tube sa bato, maaaring ilagay ang dye pababa mula sa itaas para makita ang pagsikip mula sa magkabilang panig.
- 4 Ang mga natuklasan ay iminomapa, at isang stent o drainage tube ng bato ay inilalagay o pinapalitan kung kinakailangan.

Pagkatapos ng Pagsusuri

- Magigising kayo mula sa anesthesia at kadalasan ay **makakauwi sa parehong araw** kasama ang isang kasama.
- Maaaring may **banayad na pangangati, sakit sa tagiliran, o pinkish na ihi** sa loob ng isa o dalawang araw; nakatutulong ang dagdag na tubig. Kung may stent, normal ang banayad na pangangailang umihi.
- Susuriin ng inyong siruhano ang mapa at tatalakayin ang mga susunod na hakbang para sa inyong pagpapaayos.

Tawagan ang opisina ng inyong siruhano o humingi ng tulong kung kayo ay may:

- Lagnat o panginginig
- Matindi o lumalaking pananakit sa tagiliran o tiyan
- Malakas na pagdurugo, o blood clots sa ihi
- Hirap umihi, o tuloy-tuloy na pagduwal o pagsusuka

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Iminomapa nito ang pagsikip ng ureter habang natutulog kayo (camera + contrast dye mula sa ibaba at/o itaas), para maplanuhan ng siruhano ang tamang pagpapaayos.
2. Dahil may anesthesia: sundin ang pag-aayuno at gamot, gamutin muna ang impeksiyon, iwanan ang drainage tube o stent, at mag-ayos ng sasakyan.
3. Kadalasang same-day. Normal ang banayad na pangangati, sakit sa tagiliran, o kaunting pink sa ihi sa loob ng isa o dalawang araw — uminom ng dagdag na tubig.